



YAYASAN KENDEDES MALANG
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDEDES MALANG

SK Mendiknas RI No. 47/D/O/2009

Program Studi : 1. D-III Kebidanan 2. D-III Keperawatan 3. S-1 Keperawatan

4. Profesi Ners (SK Mendikbud RI No. 224/E/O/2014)

5. Kebidanan Program Sarjana 6. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi
(SK Mendikbud RI No. 887/M/2020)

Jl. R. Panji Suroso No. 6 Malang

Telp. (0341) 488762, 480497, Fax. (0341) 488763

Nomor : 181.A.2.1/AKD/X/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo Pasurusn

Di -
Tempat

Menunjuk :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 047/D/O/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan STIKes Kendedes Malang;
2. Kalender Akademik Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Kendedes Malang TA. 2025/2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Bapak/ Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasurusn, untuk memberikan rekomendasi ijin penelitian kepada mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKes Kendedes Malang dibawah ini :

Nama : Intania Cahya Andini
NIM : 2401160877
Judul Skripsi : Pengaruh Teknik Distraksi Visual dan Terapi Bermain Mewarnai Terhadap Kecemasan Hospitalisasi pada Anak Usia Prasekolah di RS. Prima Husada Sukorejo

Pelaksanaan pada Bulan Oktober 2025.

Demikian permohonan kami, atas kebijaksanaan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, M.Kep
NIDN. 0711078807

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Ka. LPPM STIKes Kendedes Malang
2. Ka. BAAK STIKes Kendedes Malang

**PENGARUH EDUKASI PENGETAHUAN TERHADAP KECEMASAN
PASIEH PRE OPERASI KATARAK DI POLI
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO**

PROPOSAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Tinggi Sarjana Keperawatan**



DISUSUSN OLEH:

NAMA: FIRDHAUSI NUZULA

NIM : 2401160871

**SEKOLAH TINGGI KESEHATAN KANDEDES MALANG
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
2025**

PENGARUH EDUKASI PENGETAHUAN TERHADAP KECEMASAN

PASIEN PRE OPERASI KATARAK DI POLI

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PROPOSAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Tinggi Sarjana Keperawatan**



DISUSUSN OLEH:

NAMA: FIRDHAUSI NUZULA

NIM : 2401160871

**SEKOLAH TINGGI KESEHATAN KANDEDES MALANG
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal STIKes Kendedes Malang dengan judul “Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo” telah disetujui oleh pembimbing penyusunan Proposol Program Studi Keperawatan pada

Malang.....2025

Mahasiswa

Firdhausi Nuzula
NIM: 2401160871

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ns.Lembah Andriani, S.Kep. MMRS
NIDN.

Ns. Nadhifah Rahmawati, M.TR.Kep
NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal dengan judul : Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Proposal STIKes Kendedes Malang Prodi S1 Keperawatan

Telah diuji pada

Hari :

Tanggal :

Dan disahkan oleh

Ns. Luluk Nur Aini, M.Kep

(.....)

(.....)

NIDN.
Penguji I

Tanda tangan

Tanggal

Dr. Ns.Lembah Andriani, S.Kep. MMRS

(.....)

(.....)

NIDN.
Pembimbing I

Tanda tangan

Tanggal

Ns. Nadhifah Rahmawati, M.TR.Kep

(.....)

(.....)

NIDN.
Pembimbing II

Tanda tangan

Tanggal

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Keperawatan
STIKes Kendedes Malang

Ns. Putu Sintya Alinda Arsa,M.Kep
NIDN. 0711078807

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penelitian mampu menyelesaikan Proposal yang berjudul “Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo”. Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Proposal ini masih banyak kekurangan namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat menyelesaikan, baik melalui konsultasi dengan pembimbing dan membaca berbagai jurnal/literatur. Oleh karena itu ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. dr. Muljo Hadi Sungkono, Sp. OG (K), selaku Pembina Yayasan Kendedes Malang.
2. drg. Suharwati, selaku Ketua Yayasan Kendedes Malang.
3. dr. Endah Puspitorini, MScIH, DTMPH, selaku PLH STIKes Kendedes Malang.
4. Dr. Jenny J.S. Sondakh, S.Si. T, Clin.Mid, selaku Ketua STIKes Kendedes Malang.
5. Ns. Putu Sintya Arlinda Arsa, M.Kep selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan Kendedes Malang.
6. Pembimbing 1 adalah Dr. Ns. Lembah Andriani, S.Kep. MMRS saya berterimakasih atas bimbngannya.
7. Pembimbing 2 adalah Ns. Nadhifah Rahmawati, M.TR.Kep yang sudah membimbing saya, saya ucapkan terimakasih banyak.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memancurkan cinta kasih sayangnya dan do'a-do'a dalam setiap langkahku.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat masih terbatasnya ilmu dan pengalaman, oleh karena itu peneliti tidak menutup diri bila ada kritik dan saran yang bersifat membangun agar penyusunan proposal ini lebih sempurna di mas yang akan datang. Semoga penyusun proposol ini dapat bermanfaat dan berguna bagi profesi dan para pembacanya.

Malang.....2025

Firdhausi Nuzula
NIM: 2401160871

DAFTAR ISI

PROPOSAL	i
PROPOSAL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Bagi Responden	5
1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan	5
1.4.3 Bagi Instansi Kesehatan	5
1.4.4 Bagi Peneliti	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Stroke.....	7
2.1.1 Pengertian Stroke	7
2.1.2 Faktor Risiko	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Penyebab Stroke	9
2.1.4 Macam-Macam Stroke	9
2.1.5 Tanda dan Gejala Stroke	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Komplikasi Stroke.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Penatalaksanaan Stroke	Error! Bookmark not defined.
2.1.8 Pemeriksaan Penunjang Stroke	Error! Bookmark not defined.
2.2 Konsep Fungsi Motorik	11

2.2.1	Pengertian Fungsi Motorik.....	11
2.2.2	Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Motorik . Error! Bookmark not defined.	
2.2.3	Pengukuran Fungsi Motorik..... Error! Bookmark not defined.	
2.3	Konsep Terapi Teknik Bobath	15
2.3.1	Pengertian Terapi Teknik Bobath	15
2.3.2	Manfaat Terapi Teknik Bobath Error! Bookmark not defined.	
2.3.3	Cara Terapi Teknik Bobath..... Error! Bookmark not defined.	
2.4	Pengaruh Terapi Teknik Bobath Terhadap Fungsi Motorik Pada Pasien Stroke di Ruang Irna 3B RS Prima Husada Sukorejo	18
BAB III	KERANGKA KONSEP	23
3.1	Kerangka Konseptual	23
3.2	Hipotesa	24
BAB IV	METODE PENELITIAN	25
4.1	Desain Penelitian	25
4.2	Kerangka Kerja	25
4.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	26
4.3.1	Populasi	26
4.3.2	Sampel.....	27
4.3.3	Teknik Sampling	27
4.4	Kriteria Sampel	27
4.4.1	Kriterian Inklusi	27
4.4.2	Kriteria Eksklusi.....	27
4.5	Variabel Penelitian	28
4.5.1	Variabel Independen	28
4.5.2	Variabel Dependen.....	28
4.6	Definisi Operasional	28
4.7	Tempat dan Waktu Penelitian	28
4.7.1	Tempat Penelitian.....	28
4.7.2	Waktu Penelitian	28
4.8	Pengumpulan Data	29
4.8.1	Proses Pengumpulan Data.....	29
4.8.2	Alat Pengukuran Data	30

4.8.3	Uji Validitas dan Reliabilitas	31
4.9	Pengolahan Data.....	32
4.9.1	Editing.....	32
4.9.2	Coding.....	32
4.9.3	Scoring	33
4.9.4	Tabulating	33
4.10	Analisa Data.....	33
4.10.1	Analisis Univariat.....	33
4.10.2	Analisis Bivariat.....	33
4.11	Etik Penelitian	34
4.11.1	<i>Infoment Consent</i>	34
4.11.2	<i>Anonimity</i>	34
4.11.3	<i>Confidentiality</i>	35
4.11.4	<i>Beneficience</i>	35
4.11.5	<i>Justice</i>	35
4.11.6	<i>Non maleficence</i>	35
4.11.7	<i>Inducements</i>	35
	DAFTAR PUSTAKA.....	36
	LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Skema Control-Group Pretest-Posttest Design.....	17
Tabel 4.6 Definisi Operasonal.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Terapi Teknik Bobath Terhadap Fungsi Motorik Pada Pasien Stroke di Ruang Irna 3B RS Prima Husada Sukorejo	15
Gambar 4.2 Kerangka Kerja Pengaruh Terapi Teknik Boabth Terhadap Fungsi Motorik Pasiem Stroke di Ruang Irna 3B RS Prima Husada.....	18

DAFTAR SINGKATAN

AOU	: Amount of Use
CT Scan	: Computed Tomography Scan
FMA	: Fugl-Meyer Assessment
ICF	: international Classification of Functioning
QOM	: Quality of Movement
MAL	: Motor Activity Log
MAS	: Motor Assessment Scale
RSU	: Rumah Sakit Umum
RS	: Rumah Sakit
WMFT	: Wolf Motor Function Test
WSO	: World Stroke Organization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan permanen dan penyebab umum kebutaan di negara berkembang dan negara maju disebut katarak (Hasan dkk., 2024). Tindakan pembedahan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pada kasus katarak, tindakan ini dapat berpotensi menyebabkan reaksi pada fisik dan psikologi (Azizah & Zainuri, 2023). Operasi katarak merupakan salah satu prosedur yang paling efektif, pada tindakan ini pasien mengalami emosi negatif yang kuat, seperti ketakutan dan kecemasan (Aini, 2024).

Penyakit katarak salah satu penyakit yang menyebabkan kebutaan nomor satu di dunia. Data yang didapatkan pada WHO tahun 2018 adalah sekitar 285 juta orang yang mengalami gangguan penglihatan di dunia, sekitar 39 juta orang mengalami kebutaan dan 246 juta orang memiliki *low vision* (WHO, 2018). Data katarak yang ada di Indonesia dari hasil survei *Kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness* (RAAB) yang dilakukan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 oleh persatuan Dokter Mata Indonesia dan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan di 15 Provinsi di Indonesia sebanyak 81% kasus dan kasus katarak di Jawa Timur dengan penyebab katarak yang tidak tertangani sebanyak 4,4% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Studi kasus pada rumah sakit Prima Husada Sukorejo pada bulan Juli-Agustus

sebanyak 30 orang mendapatkan edukasi pre operasi katarak akan tetapi mereka mengalami kecemasan sedang hingga berat (Rekamedia Poli, 2025).

Penyebab penyakit katarak adalah usia, traumatik, terapi kortikosteroid metabolik, kelainan sistemik atau metabolik, rokok, konsumsi alkohol, dan tetapi dapat terjadi secara kongenital akibat virus di masa pertumbuhan janin, genetik, dan gangguan perkembangan (Hasan dkk., 2024). Katarak yang dibiarkan dapat mengakibatkan buta permanen, maka dari itu dilakukan operasi katarak untuk mengurangi risiko kebutaan (Azizah & Zainuri, 2023). Prosedur pembedahan yang akan dilakukan pada pasien dapat mengalami rasa cemas dan takut. Kecemasan dan ketakutan akan operasi katarak mungkin menjadi alasannya membatalkan prosedur (Aini, 2024).

Edukasi kesehatan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku edukasi atau promosi kesehatan (Hasan dkk., 2024). Pemberian edukasi pre operasi katarak adalah salah satu untuk mencegah pasien menarik dari operasi, memberikan pasien informasi yang dapat dipercaya, dapat diakses tentang katarak, metode pengobatannya, dan berdampak positif untuk mengurangi rasa cemas dan takut akan pembedahan (Azizah & Zainuri, 2023). Edukasi kesehatan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat edukasi, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, kepercayaan masyarakat, dan ketersediaan waktu di masyarakat (Aini, 2024).

Studi pendahuluan yang dilakukan penelitian oleh Astuti & Muzaenah (2025) yang dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai dengan Februari

2024 di klinik mata Instalasi Rawat Jalan RSI Purwokerto. Didapatkan hasil nilai p dari uji hipotesis adalah 0,000, sehingga diinterpretasikan bahwa ada perbedaan tingkat kecemasan antara sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Studi pendahuluan yang dilakukan penelitian oleh Hasan dkk (2024) berlokasi di Rumah Sakit Mata Lampung Eye Center Lampung yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2023. Hasil Uji *Paired T-Test* menunjukkan p -value $< 0,005$ artinya ada Pengaruh Edukasi Tindakan Phacomulsifikasi Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Op Katarak di Rumah Sakit Mata LEC. Studi pendahuluan yang dilakukan penelitian oleh Yahya dkk (2023) pada tanggal 31 Maret 2022 sampai 16 September 2022 di RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen. Hasil analisa statistik menggunakan *chi square test* didapatkan p value = $0,001 < \alpha = 0,05$, maka H^0 ditolak dan H^a diterima yang berarti ada hubungan pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada lansia pre operasi katarak di RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil judul “pengaruh edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak di Poli RS Prima Husada Sukorejo”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak di Poli RS Prima Husada Sukorejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis pengaruh edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak di Poli RS Prima Husada Sukorejo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kecemasan sebelum edukasi pengetahuan pasien pre operasi katarak.
2. Mengidentifikasi kecemasan sesudah edukasi pengetahuan pasien pre operasi katarak.
3. Menganalisis pengaruh edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak di Poli RS Prima Husada Sukorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Responden

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman responden terkait edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan baru bagi institusi dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti dan sumber bacaan untuk mahasiswa terkait edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak.

1.4.3 Bagi Instansi Kesehatan

Sebagai acuan dan referensi instansi kesehatan dalam edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak.

1.4.4 Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada peneliti dalam menerapkan edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Katarak

2.1.1 Pengertian Katarak

Katarak adalah salah satu penyakit karena kekeruhan pada lensa mata yang berada di dalam bola mata. Kekeruhan lensa atau katarak akan mengakibatkan cahaya terhalang untuk masuk ke dalam mata sehingga penglihatan menjadi menurun (Lestari dkk., 2024).

Katarak merupakan opasitas pada lensa yang menyebabkan penurunan jumlah atau pembiasan cahaya yang masuk melalui media refraksi sehingga menurunkan kemampuan penglihatan (Yahya, 2023).

2.1.2 Jenis-Jenis Katarak

Jenis-jenis katarak menurut Lestari dkk (2024) antara lain:

1. Katarak Senilis

Katarak senilis adalah jenis katarak yang paling sering dijumpai. Satu-satunya gejala adalah distorsi penglihatan dan penglihatan yang semakin kabur.

2. Katarak Anak-Anak

Katarak kongenital adalah katarak karena disebabkan oleh penyakit infeksi, metabolik, atau berkaitan dengan berbagai sindrom. Katarak didapat karena disebabkan oleh trauma baik tumpul maupun tembus.

3. Katarak Traumatik

Paling sering disebabkan oleh cedera benda asing di lensa atau trauma tumpul terhadap bola mata. Lensa menjadi putih segera setelah masuknya benda asing karena lubang pada kapsul lensa menyebabkan *humor aqueus* dan kadang-kadang korpus vitreum masuk kedalam struktur lensa.

4. Katarak Komplikata

Katarak komplikata adalah katarak sekunder akibat penyakit *intraokular* pada fisiologi lensa. Katarak biasanya berawal di daerah sub kapsul posterior dan akhirnya mengenai seluruh struktur lensa. Penyakit intraokular yang sering berkaitan dengan pembentukan katarak adalah uveitis kronik atau rekuren, glaukoma, retinitis pigmentosa dan pelepasan retina.

5. Katarak Akibat Penyakit Sistemik

Katarak bilateral dapat terjadi karena gangguan-gangguan sistemik berikut: diabetes mellitus, *hipoparatiroidisme*, distrofi miotonik, dermatitis atropik, galaktosemia, dan syndrome lowe, werner atau down.

6. Katarak Toksik

Kasus katarak toksik jarang terjadi. Kasus yang dialami pada tahun 1930-an sebagai akibat penelanan dinitrofenol (suatu obat yang digunakan untuk menekan nafsu makan). Kortokosteroid yang diberikan dalam waktu lama, baik secara sistemik maupun dalam bentuk tetes yang dapat menyebabkan kekeruhan lensa.

7. Katarak Ikutan

Katarak ikutan menunjukkan kekeruhan kapsul posterior akibat katarak traumatik yang terserap sebagian atau setelah terjadinya ekstraksi katarak ekstrakapsular.

2.1.3 Penyebab Katarak

Penyebab terjadinya katarak bermacam-macam yaitu usia lanjut, tetapi dapat terjadi secara kongenital akibat infeksi virus di masa pertumbuhan janin, genetik, dan gangguan perkembangan. Dapat juga terjadi karena traumatik, terapi kortikosteroid metabolik, dan kelainan sistemik atau metabolik, seperti diabetes mellitus, galaktosemia, dan distrofi miotonik. Rokok dan konsumsi alkohol meningkatkan resiko katarak (Lestari dkk., 2024).

2.1.4 Manifestasi Klinis Katarak

Manifestasi klinis katarak menurut Lestari dkk (2024) antara lain:

1. Pandangan mata menjadi kabur.
2. Merasa silau bila terkena cahaya
3. Mata melihat cincin dari sumber cahaya.
4. Gambar menjadi ganda.
5. Saat malam penglihatan nampak buruk.
6. Penglihatan ganda atau banyak gambar dalam satu mata.

2.1.5 Komplikasi Katarak

Komplikasi katarak menurut Lestari dkk (2024) antara lain:

1. Glukoma adalah peningkatan saraf optik dan kebutaan bila tidak teratasi.
2. Uveitis yaitu inflamasi salah satu struktur traktus uvea.

2.1.6 Penatalaksanaan Katarak

Penatalaksanaan untuk katarak salah satunya adalah operasi. Operasi katarak ini bertujuan untuk menghilangkan lensa yang berwarna (Lestari dkk, 2024).

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang Katarak

Pemeriksaan penunjang katarak menurut Lestari dkk (2024) antara lain:

1. Pemeriksaan darah rutin yang terdiri dari hemoglobin, leukosit, trombosit, dan gula darah sewaktu dilakukan pada pasien yang akan dilakukan operasi katarak.
2. Pemeriksaan ultrasonografi ocular dilakukan jika dicurigai terdapat patologi pada retina atau vitreus terkait temuan anamnesis dan kondisi sistemik pasien namun tidak dapat dilakukan pemeriksaan funduskopi karena kekeruhan media refraksi. Jika terdapat katarak total monocular juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG karena dugaan katarak terjadi akibat komplikasi masalah lain disegmen posterior atau akibat trauma.
3. Pemeriksaan macula (*optical coherene tomography*) dilakukan jika derajat kekeruhan katarak didapatkan ringan namun penurunan tajam penglihatan lebih buruk dari yang seharusnya dan evaluasi patologi macula tidak jelas akibat kekeruhan.
4. Pemeriksaan specular mikroskopi untuk menghitung kerapatan sel endotel kornea. Pemeriksaan ini dilakukan jika dicurigai adanya patologi pada endotel kornea dan pada kasus dengan penyulit. Setiap tindakan operasi intraokular, termasuk katarak akan

menyebabkan berkurangnya sel endotel sehat pasca operasi, sedangkan jumlah serta kualitas sel endotel sangat penting untuk menjaga kejernihan kornea.

2.2 Konsep Pre Operasi

2.2.1 Pengertian Pre Operasi

Operasi adalah tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh. Pre operasi adalah bagian dari keperawatan perioperatif dan persiapan awal sebelum melakukan tindakan operasi (Hasan dkk., 2024). Pre operasi adalah tahapan yang dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi (Wihartini, 2022).

2.2.2 Persiapan Pre Operasi

Persiapan dan perawatan pre operasi menurut Hasan dkk (2024) antara lain:

1. Persiapan Mental

Persiapan mental merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses persiapan operasi karena mental pasien yang tidak siap atau labil dapat berpengaruh terhadap kondisi fisiknya. Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis.

2. Persiapan Fisik

Status kesehatan fisik secara umum dilakukan pengecekan meliputi identitas klien, riwayat penyakit seperti kesehatan masa

lalu, riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik lengkap, antara lain status hemodinamika, status kardiovaskuler, status pernafasan, fungsi ginjal dan hepatic, fungsi endokrin, fungsi imunologi, dan lainlain. Selain itu pasien harus istirahat yang cukup karena dengan istirahat yang cukup pasien tidak akan mengalami stres fisik, tubuh lebih rileks sehingga bagi pasien yang memiliki riwayat hipertensi, tekanan darahnya dapat stabil dan pasien wanita tidak akan memicu terjadinya haid lebih awal.

Status nutrisi ditentukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan, lipat kulit trisep, lingkar lengan atas, kadar protein darah (albumin dan globulin) dan keseimbangan nitrogen. Segala bentuk defisiensi nutrisi harus di koreksi sebelum pembedahan untuk memberikan protein yang cukup untuk perbaikan jaringan. Kondisi gizi buruk dapat mengakibatkan pasien mengalami berbagai komplikasi pasca operasi dan mengakibatkan pasien menjadi lebih lama dirawat di rumah sakit.

Keseimbangan cairan perlu diperhatikan *balance* cairan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan input dan output cairan. Kadar elektrolit serum harus berada dalam rentang normal. Keseimbangan cairan dan elektrolit terkait erat dengan fungsi ginjal. Ginjal berfungsi mengatur mekanisme asam basa dan ekskresi metabolik obat-obatan anastesi. Pencukuran daerah operasi bisa dilakukan atau tidak tergantung daerah mana yang mau dioperasi.

Kebersihan tubuh pasien sangat penting untuk persiapan operasi karena tubuh yang kotor dapat merupakan sumber kuman dan dapat mengakibatkan infeksi pada daerah yang di operasi. Pada pasien yang kondisi fisiknya kuat diajurkan untuk mandi sendiri dan membersihkan daerah operasi dengan lebih seksama. Sebaliknya jika pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan *personal hygiene* secara mandiri maka perawat akan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan *personal hygiene*.

3. Sebelum Masuk Kamar Bedah

Persiapan penunjang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan pembedahan. Tanpa adanya hasil pemeriksaan penunjang, maka dokter bedah tidak mungkin bisa menentukan tindakan operasi yang harus dilakukan pada pasien. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud adalah berbagai pemeriksaan radiologi, laboratorium maupun pemeriksaan lain seperti EKG, dan lain-lain. Sebelum dokter mengambil keputusan untuk melakukan operasi pada pasien, dokter melakukan berbagai pemeriksaan terkait dengan keluhan penyakit pasien sehingga dokter bisa menyimpulkan penyakit yang diderita pasien.

Setelah dokter bedah memutuskan untuk dilakukan operasi maka dokter anastesi berperan untuk menentukan apakah kondisi pasien layak menjalani operasi. Untuk itu dokter anastesi juga memerlukan berbagai macam pemeriksaan laboratorium terutama pemeriksaan masa perdarahan (*bledding time*) dan masa

pembekuan (*clotting time*) darah pasien, elektrolit serum, hemoglobin, protein darah, dan hasil pemeriksaan radiologi berupa foto thoraks dan EKG.

4. Pemeriksaan Status Anestesi

Pemeriksaan status fisik untuk pembiusan perlu dilakukan untuk keselamatan selama pembedahan. Sebelum dilakukan anestesi demi kepentingan pembedahan, pasien akan mengalami pemeriksaan status fisik yang diperlukan untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap diri pasien. Pemeriksaan yang biasa digunakan adalah pemeriksaan dengan menggunakan metode ASA (*American Society of Anesthesiologist*). Pemeriksaan ini dilakukan karena obat dan teknik anestesi pada umumnya akan mengganggu fungsi pernafasan, peredaran darah dan sistem saraf.

5. Inform Consent

Selain dilakukannya berbagai macam pemeriksaan penunjang terhadap pasien, hal lain yang sangat penting terkait dengan aspek hukum dan tanggung jawab dan tanggung gugat, yaitu Inform Consent. Baik pasien maupun keluarganya harus menyadari bahwa tindakan medis, operasi sekecil apapun mempunyai resiko. Oleh karena itu setiap pasien yang akan menjalani tindakan medis, wajib menuliskan surat pernyataan persetujuan dilakukan tindakan medis (pembedahan dan anestesi). Inform Consent sebagai wujud dari upaya rumah sakit menjunjung tinggi aspek etik hukum, maka

pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien wajib untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan operasi.

2.3 Konsep Kecemasan

2.3.1 Pengertian Kecemasan

Kecemasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan, tidak enak, khawatir dan gelisah. Perasaan tidak menyenangkan itu dapat berupa sumber-sumber yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sumber dari luar dapat berupa terpapar infeksi virus dan bakteri, polusi, gangguan keamanan, masalah tempat tinggal, pakian dan kecelakaan. Sumber kecemasan dari dalam dapat berupa gangguan fisiologis seperti jantung, sistem imun, temperatur, regulasi dan perubahan fisiologis lainnya (Hasan dkk., 2024).

Kecemasan merupakan respon dari stres yang tak dapat dihindari pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana seseorang mengatasi stress dan kecemasan adalah hal yang penting sehingga kita dapat mengerti bagaimana individu dapat menjalankan peran personal, sosial dan pekerjaan (Nugraha dkk., 2024).

2.3.2 Klasifikasi Kecemasan

Empat level tingkat kecemasan antara lain adalah: Kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik menurut Nugraha dkk 2024) antara lain:

1. Kecemasan Ringan

Kecemasan ringan adalah kecemasan yang terjadi akibat kejadian sehari-hari selama hidup. Pada level ini, seseorang akan

merasa waspada dan pandangan perseptual orang tersebut meningkat.

2. Kecemasan Sedang

Kecemasan sedang adalah meningkat kecemasan dimana individu mulai mengalami ketegangan yang meningkat, fokus perhatian mulai menyempit, dan kemampuan berpikir mulai terpengaruh akan tetapi masih dapat diarahkan.

3. Kecemasan Berat

Kecemasan berat adalah tingkat kecemasan di mana individu mengalami gangguan signifikan dalam berpikir, berkonsentrasi, dan berfungsi secara normal. Pada tahap ini, persepsi menjadi sangat menyempit, fokus hanya pada rasa takut atau ancaman, dan respon terhadap stimulus luar sangat terbatas.

4. Panik

Panik adalah salah satu kondisi emosional ekstrem terhadap ancaman nyata atau yang dirasakan, yang ditandai dengan rasa takut intens, tiba-tiba, dan tidak terkendali. Panik biasanya muncul secara mendadak dan dapat menyebabkan gejala fisik yang parah serta gangguan perilaku sementara.

2.3.3 Faktor Kecemasan

Faktor yang mempengaruhi kecemasan menurut Nugraha dkk 2024) antara lain:

1. Usia

Usia seseorang yang lebih muda ternyata lebih muda mengalami gangguan kecemasan daripada seseorang yang berusia tua. Hal lainnya berpengaruh oleh kepribadian individu seseorang, pada usia muda seseorang cenderung memiliki sifat yang labil sehingga dalam mengelola cemas atau stress masih kurang, tetapi tidak menutup kemungkinan juga usia muda dapat mengelola kecemasan dengan baik, hal ini sehingga perlunya peranan perawat dalam membantu pasien preoperasi agar tidak mengalami kecemasan atau menurunkan kecemasannya.

2. Jenis Kelamin

Kecemasan dapat dipengaruhi oleh asam lemak bebas dalam tubuh. Pria mempunyai produksi asam lemak bebas lebih banyak dibanding wanita sehingga pria beresiko mengalami kecemasan yang lebih tinggi daripada wanita.

3. Edukasi

Seorang yang beredukasi tinggi akan menggunakan coping lebih baik sehingga memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang beredukasi rendah.

4. Sistem Pendukung

Sistem pendukung merupakan kesatuan antara individu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar yang memberikan pengaruh pada individu, sehingga melakukan sesuatu. Sistem pendukung tersebut akan mempengaruhi mekanisme coping

individu sehingga mampu memberi gambaran kecemasan yang berbeda.

2.3.4 Pengukuran Kecemasan

Pengukuran kecemasan menggunakan *Hamilton Anxiety Rating Scale* merupakan salah satu skala yang dikembangkan untuk mengukur tingkat keparahan kecemasan. Skala kecemasan ini terdiri dari 14 item yang masing-masing item merupakan gejala kecemasan dan mengukur kedua kecemasan psikis (mental agitasi dan tekanan psikologis) dan kecemasan somatik (keluhan fisik berkaitan dengan kecemasan). Setiap item yang dinilai skor 0 tidak ada gejala sama sekali, skor 1 satu dari gejala yang ada, skor 2 separuh dari gejala yang ada, skor 3 lebih dari separuh gejala yang ada, dan skor 4 semua gejala ada. Penilaian hasil yaitu dengan menjumlahkan nilai skor item 1 sampai dengan 14 dengan ketentuan sebagai yaitu skor kurang dari 6 : tidak ada kecemasan, skor 6-14 : kecemasan ringan, skor 15 -27 : kecemasan sedang, dan skor lebih dari 28 : kecemasan berat (Kautsar, 2015 Septianawati dkk., 2023).

2.4 Konsep Edukasi

2.4.1 Pengertian Edukasi

Edukasi adalah kegiatan dibidang penyuluhan Kesehatan umum dengan tujuan menyadarkan dan mengubah sikap dan perilaku masyarakat (Hasan dkk., 2024). Edukasi pra operasi merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan perioperatif yang membantu pasien

memahami prosedur operasi, mempersiapkan diri secara emosional, serta meningkatkan hasil pascaoperasi (Wihartini, 2022).

2.4.2 Tujuan Edukasi Pre Operasi

Meningkatkan pengetahuan pasien mengenai prosedur operasi katarak, Mengurangi kecemasan dan ketakutan pasien terhadap tindakan medis. Meningkatkan kerja sama antara pasien dan tenaga Kesehatan. Meningkatkan kemandirian pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dirinya (Hasan dkk., 2024).

2.4.3 Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi menurut Wihartini (2022) antara lain:

1. Fungsi Edukasi Promotif

Fungsi edukasi promotif adalah memberikan informasi atau pengetahuan kepada individu, kelompok, atau masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah munculnya masalah kesehatan sebelum terjadi

2. Fungsi Edukasi Preventif

Fungsi edukasi preventif adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada individu atau masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan, baik sebelum terjadi (pencegahan primer), saat awal terjadi (pencegahan sekunder), maupun untuk mencegah komplikasi lebih lanjut (pencegahan tersier).

3. Fungsi Edukasi Kuratif

Edukasi kuratif adalah pemberian informasi kepada pasien yang sudah mengalami gangguan kesehatan atau penyakit, dengan tujuan membantu proses penyembuhan dan pengobatan secara optimal.

4. Fungsi Edukasi Rehabilitatif

Edukasi rehabilitatif adalah edukasi yang diberikan kepada pasien yang sedang dalam masa pemulihan atau pasca pengobatan, agar bisa kembali ke fungsi normal dan mencegah kekambuhan atau disabilitas.

2.4.4 Metode Pemberian Edukasi

Metode pemberian edukasi menurut Wihartini (2022) antara lain:

1. Metode Individual

Metode individual adalah metode edukasi yang dilakukan secara perorangan yang dilakukan oleh kesehatan (misalnya perawat) dengan satu pasien.

2. Metode Kelompok

Metode kelompok adalah salah satu metode edukasi yang diberikan kepada lebih dari satu orang sekaligus dengan materi yang sama.

2.4.5 Media Edukasi

Media edukasi menurut Wihartini (2022) antara lain:

1. Media cetak adalah alat bantu pembelajaran atau penyuluhan yang berupa bahan tertulis atau materi tercetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada individu atau

kelompok. Tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mendukung kesehatan.

2. Media audio-visual adalah salah satu media untuk pembelajaran yang menggabungkan unsur suara (audio) dan gambar atau video (visual) untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh pasien atau masyarakat.
3. Media digital adalah media pembelajaran kesehatan yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan informasi kepada individu atau kelompok yang menggunakan cara interaktif maupun non-interaktif. Memakai perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, komputer, atau media online lainnya.
4. Media demonstrasi langsung adalah media penyampaian informasi kesehatan yang dilakukan dengan peragaan nyata atau langsung oleh tenaga kesehatan kepada pasien atau kelompok sasaran. Media ini bertujuan agar mereka dapat melihat, memahami, dan menirukan keterampilan atau tindakan kesehatan tertentu secara benar.
5. Media lingkungan adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui elemen-elemen yang ada di sekitar lingkungan fisik. Media ini bertujuan agar individu atau kelompok secara tidak langsung menerima informasi edukatif dan terpacu untuk berperilaku sehat.

2.5 Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo

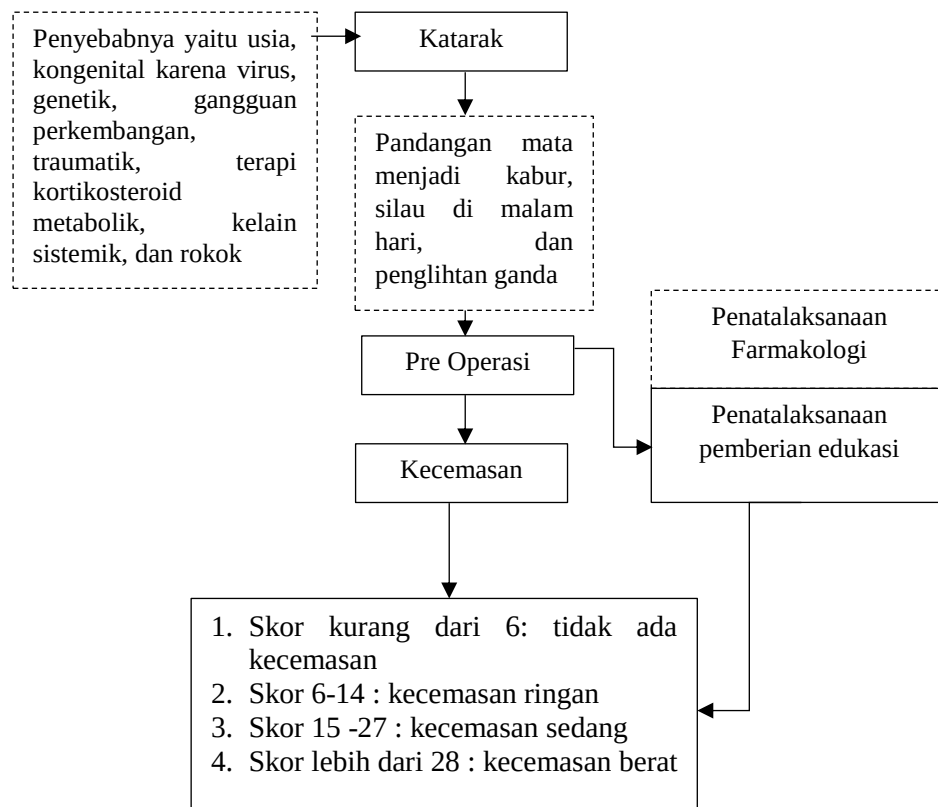
Tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Kecemasan yang dialami oleh pasien pre operasi dapat berkurang dengan memberikan edukasi sebelum operasi (Hasan dkk., 2024). Edukasi pra operasi adalah bagian penting dalam asuhan keperawatan perioperatif yang membantu pasien memahami prosedur operasi, mempersiapkan diri secara emosional, serta meningkatkan hasil pascaoperasi (Wihartini, 2022). Edukasi pra operasi adalah intervensi keperawatan yang memberikan pemahaman kepada pasien mengenai prosedur, risiko, persiapan, proses pemulihan pasca-operasi, dan edukasi pra-operasi penting untuk membantu pasien lebih siap secara mental dan fisik (Arif dkk., 2022). Edukasi pra-operasi merupakan proses pemberian informasi secara sistematis kepada pasien sebelum menjalani tindakan pembedahan, dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan psikologis, dan menurunkan tingkat kecemasan pasien terhadap prosedur yang akan dijalani (Deliya dkk., 2024).

BAB III

KERANGKA KONSEP

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rangkaian konsep atau konstruk yang saling berhubungan dan membentuk suatu gambaran sistematis mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2020).



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo

: diteliti
 : tidak diteliti

Penyebab katarak antara lain usia, kongenital karena virus, genetik, gangguan perkembangan, traumatik, terapi kortikosteroid metabolik, kelain sistemik, dan rokok. Manifestasiklinis dari katarak adalah Pandangan mata menjadi kabur, silau

di malam hari, dan penglihatan ganda. Katarak dapat disembuhkan dengan tindakan operasi. Pada tindakan operasi ada pre-operasi dan post operasi. Pre operasi adalah tahapan yang dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. Pasien katarak saat pre operasi sering mengalami cemas dan takut. Kriteria kecemasan ada tiga yaitu tingkat kecemasan ringan, tingkat kecemasan sedang, dan tingkat kecemasan berat. Mengurangi rasa cemas dapat diberikan edukasi pre operasi katarak yang bertujuan untuk membuat pasien katarak menjadi tenang.

3.2 Hipotesa

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan data (Nursalam, 2020).

H₁ = Ada pengaruh edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak di Poli RS Prima Husada Sukorejo

H₀ = Tidak ada pengaruh edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak di Poli RS Prima Husada Sukorejo

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan adalah pre eksperimen dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan terhadap sesuatu, tetapi peneliti tidak dapat mengontrol secara penuh semua variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2020).

Desain penelitian pre eksperimen menggunakan rancangan penelitian *pretest-posttest one group design* yaitu terdapat satu kelompok eksperimen yaitu kelompok perlakuan. Sebelum memberikan intervensi dilakukan pengukuran kecemasan dengan kuesioner. Setelah itu peneliti memberikan edukasi pre operasi katarak pada pasien di ruang poli. Setelah pemberian terapi ini dilakukan pengukuran kecemasan dengan kuesioner. Penelitian ini memiliki tujuan untuk pengaruh edukasi pengetahuan terhadap kecemasan pasien pre operasi katarak di Poli RS Prima Husada Sukorejo.

Tabel 4.1 Skema One-Group Pretest-Posttest Design

Pretest	Perlakuan	Post test
X1	Y	X2

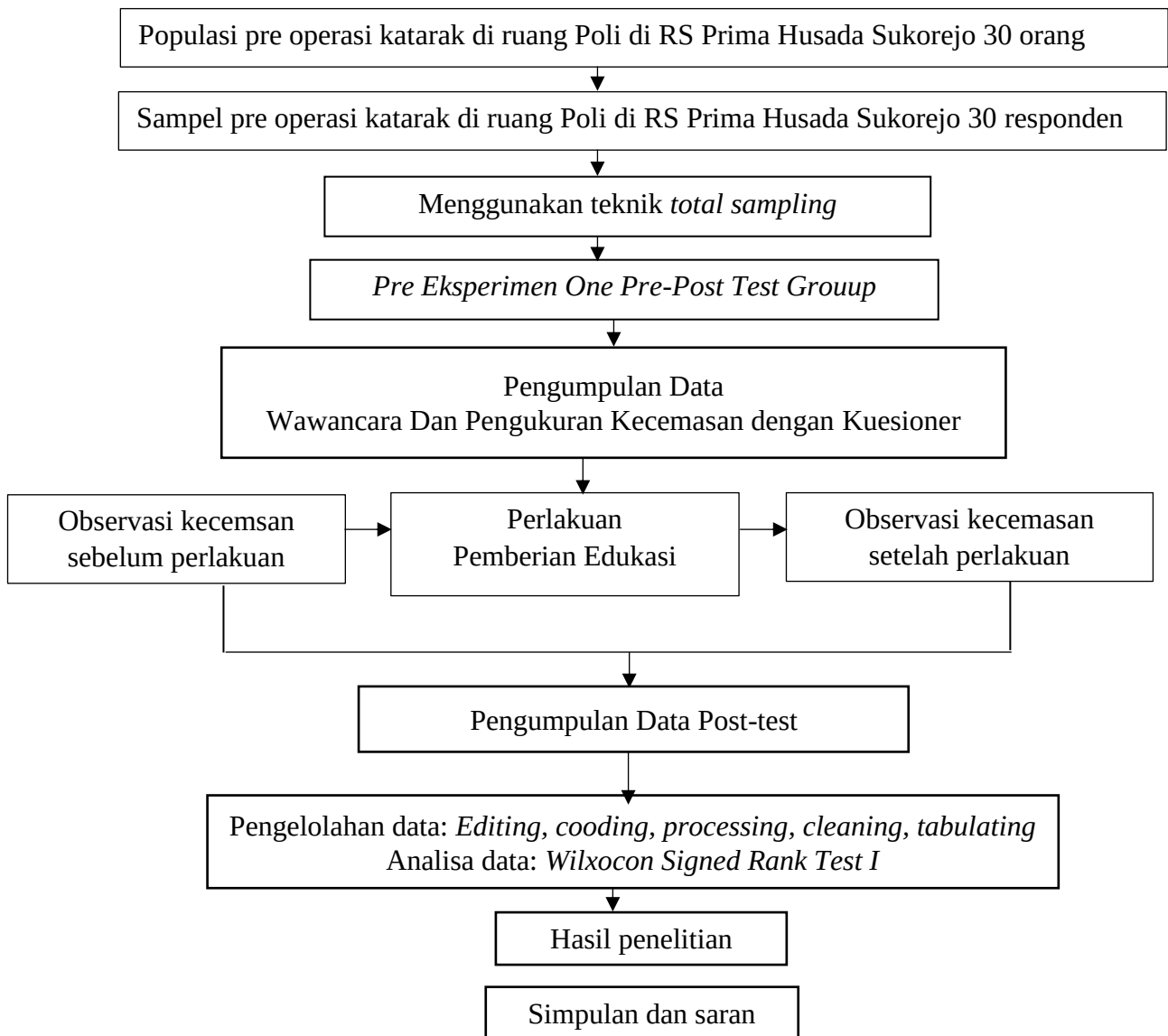
Keterangan

X1 : Pengukuran kecemasan sebelum pemberian edukasi pre operasi

Y : Pemberian edukasi pre operasi durasi 15-20 menit.

X2 : Pengukuran kecemasan sesudah pemberian edukasi pre operasi

4.2 Kerangka Kerja



Gambar 4.2 Kerangka Kerja Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

4.3.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah pasien pre operasi katarak yang terdata di ruangan Poli RS Primas Husada Sukorejo sebanyak 30 orang.

4.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan adalah pasien pre operasi katarak yang terdata di ruangan Poli RS Primas Husada Sukorejo sebanyak 30 responden.

4.3.3 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel memakai jumlah populasi (Sugiyono, 2020).

4.4 Kriteria Sampel

4.4.1 Kriterion Inklusi

Kriteria inklusi pada penelitian ini antar lain:

1. Responden yang kooperatif dan bersedia jadi responden.
2. Lama sakit 1 tahun
3. Usia responden 35-60 tahun.
4. Responden kecemasan sedang skor 18-24.
5. Responden pre operasi katarak.

4.4.2 Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi dan indikator penelitian ini antara lain:

1. Responden yang tidak kooperatif.
2. Keadaan responden tidak stabil.
3. Kecemasan berat.

4.5 Variabel Penelitian

4.5.1 Variabel Indenpenden

Variabel indenpenden pada penelitian ini adalah pemberian edukasi.

4.5.2 Variabel Dependen

Variabel denpenden pada penelitian ini adalah kecemasan.

4.6 Definisi Operasional

Tabel 4.6 Definisi Operasonal

Variabel	Definisi Operasional	Prameter	Instrumen	Skala	Skor
Variabel independent: pemberian edukasi	Merupakan pemberian pendidikan sebelum melakukan tindakan operasi	Leaflet	Observasi	-	-
Variabel dependen: kecemasan	Suatu suasana yang tidak nyaman	HARS	Kuesioner HARS	Rasio	Skor kurang dari 6: tidak ada kecemasan Skor 6-14: kecemasan ringan Skor 15 -27 : kecemasan sedang Skor lebih dari 28 : kecemasan berat

4.7 Tempat dan Waktu Penelitian

4.7.1 Tempat Peneltian

Penelitian ini dilakukan di ruangan poli rumah sakit Prima Husada Sukorejo.

4.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dengan pembuatan proposal pada bulan Juni 2025. Dilanjutkan dengan pengambilan data penelitian dibulan September 2025. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2025.

4.8 Pengumpulan Data

4.8.1 Proses Pengumpulan Data

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perizinan

- 1) Peneliti mengajukan judul terlebih dahulu pada institusi pendidikan STIKes Kendedes.
- 2) Peneliti meminta surat pengajuan permohonan izin penelitian dan studi pendahuluan di institusi pendidikan STIKes Kendedes.
- 3) Setelah mendapat surat izin dari institusi pendidikan peneliti membawa surat tembusan dari institusi ditujukan kepada Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
- 4) Setelah mendapat surat izin dari kepada Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo kemudian membawa surat tembusan ke kepala ruangan poli rumah sakit Prima Husada Sukorejo bahwa akan melakukan penelitian di ruangan poli.
- 5) Penelitian membuat proposal dengan bimbingan dari institusi pendidikan. Setelah itu proposal diajukan terlebih dahulu kemudian dilakukan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pada bulan September peneliti mensurve data responden yang ada di ruangan poli RS Prima Husada Sukorejo.

- 2) Setelah itu peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada responden dan keluarga responden.
- 3) Responden yang bersedia diminta untuk menandatangani lembar persetujuan responden dan peneliti melakukan kontrak waktu untuk pre-test dan intervensi pada pagi hari jam 07.00-08.30 WIB.
- 4) Penelitian ini dilakukan selama 3 hari. Hari pertama pasien yang diberi edukasi sebanyak 10 orang. Hari kedua pasien yang diberi sebanyak 10 orang. Hari ketiga pasien yang diberi sebanyak 10 orang.
- 5) Setelah itu pemberian edukasi akan diberikan selama 1 hari dengan durasi 15-20 menit selama 1x sehari.
- 6) Setelah pemberian intervensi pemberian edukasi di hari pertama langsung dilakukan post-test. Hari kedua setelah diberi edukasi dilakukan post-test. Hari ketiga setelah diberi edukasi dilakukan post-test.

4.8.2 Alat Pengukuran Data

Penelitian ini untuk mengambil data menggunakan wawancara, leaflet, lembar kuesioner, dan lembar observasi. Data demografi mencakup nama, jenis kelamin, usia lama penyakit. Alat pengukuran yang digunakan mengukur kecemasan menggunakan kuesioner *Hamilton Anxiety Rating Scale*. Pengukuran kecemasan menggunakan merupakan salah satu skala yang dikembangkan untuk mengukur tingkat keparahan

kecemasan. Skala kecemasan ini terdiri dari 14 item yang masing-masing item merupakan gejala kecemasan dan mengukur kedua kecemasan psikis (mental agitasi dan tekanan psikologis) dan kecemasan somatik (keluhan fisik berkaitan dengan kecemasan). Setiap item yang dinilai skor 0 tidak ada gejala sama sekali, skor 1 satu dari gejala yang ada, skor 2 separuh dari gejala yang ada, skor 3 lebih dari separuh gejala yang ada, dan skor 4 semua gejala ada. Penilaian hasil yaitu dengan menjumlahkan nilai skor item 1 sampai dengan 14 dengan ketentuan sebagai yaitu skor kurang dari 6 : tidak ada kecemasan, skor 6-14 : kecemasan ringan, skor 15 -27 : kecemasan sedang, dan skor lebih dari 28 : kecemasan berat (Kautsar, 2015 Septianawati dkk., 2023).

4.8.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan pada kuesioner kecemasan HARS tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena kuesioner HARS merupakan kuesioner pengukur tingkat kecemasan yang sudah baku. Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) yang dilakukan dengan uji corrected item total correlation bertanda positif dan lebih besar dari 0.05, hasil ujivaliditas adalah 0,208-0,589. Memiliki nilai positif dan lebih besar dari syarat 0.05 dan diuji untuk reliabilitas dengan hasil cronbach's Alpha sebesar 0.793 dan terbukti reliable dengan hasil >0.6 (Kautsar, 2015 dalam Septianawati dkk., 2023).

4.9 Pengolahan Data

4.9.1 Editing

Peneliti memeriksa kelengkapan kuesioner yang telah diberikan kepada responden, meliputi identitas responden dan pertanyaan yang diisi responden. Peneliti juga memastikan bahwa kuesioner diisi sesuai dengan petunjuk.

4.9.2 Coding

Peneliti memberikan kode setiap kriteria yang dipergunakan, maka peneliti dipermudahkan untuk menganalisis.

1. Data Umum

1) Jenis Kelamin

Perempuan : 1

Laki-laki : 2

2) Usia

35-45 tahun : 1

46-50 tahun : 2

51-60 tahun : 3

3) Lama Penyakit

< 1 tahun : 1

>1 tahun : 2

2. Data Khusus

Kecemasan

Skor < 5 : tidak ada kecemasan : 1

Skor 6-14 : kecemasan ringan	: 2
Skor 15 -27 : kecemasan sedang	: 3
Skor > 28 : kecemasan berat	: 4

4.9.3 Scoring

Tahap scoring dalam penelitian ini adalah proses pemberian skor atau nilai numerik terhadap data yang telah dikodekan (Nursalam, 2020).

Skor < 5 : tidak ada kecemasan	: 1
Skor 6-14 : kecemasan ringan	: 2
Skor 15 -27 : kecemasan sedang	: 3
Skor > 28 : kecemasan berat	: 4

4.9.4 Tabulating

Dari data mentah dilakukan pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan di analisis.

4.10 Analisa Data

4.10.1 Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui karakteristik responden berupa data demografi dan proposi data hasil penelitian dari masing-masing variable peneliti dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

4.10.2 Analisis Bivariat

Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji yang sesuai. Sebelum dilakukan Analisa data terlebih dahulu peneliti

melakukan uji normalitas dan homogenitas data. Uji normalitas menggunakan *Shapiro wilk* karena sampel < 50 , apabila signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan untuk melihat perbedaan perlakuan masing-masing variabel penelitian pada tiap kelompok sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan uji *Wilcoxon*, apabila data tidak terdistribusi normal.

4.11 Etik Penelitian

Etika penelitian adalah seperangkat prinsip, norma, dan pedoman moral yang mengatur bagaimana suatu penelitian dilakukan agar menjaga integritas ilmiah, melindungi hak-hak subjek penelitian, dan menghindari tentang penyalahgunaan data dan hasil penelitian (Gustari & Riswanto, 2024). Konsep-konsep nilai etik penelitian antara lain:

4.11.1 *Informed Consent*

Informed consent adalah bentuk persetujuan yang diberikan peneliti ke responden. *Informed consent* diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan dari *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya.

4.11.2 *Anonymity*

Anonymity atau tanpa nama adalah suatu jaminan untuk penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

4.11.3 Confidentiality

Confidentiality (kerahasiaan) merupakan jaminan untuk memberikan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

4.11.4 Beneficience

Prinsip ini menuntut peneliti untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan manfaat, baik yang menguntungkan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

4.11.5 Justice

Penelitian ini peneliti harus bersikap adil kepada responden, dan responden akan mendapat penjelasan.

4.11.6 Non maleficence

Kewajiban untuk tidak membahayakan responden penelitian. Responden berhak memutuskan dengan sukarela dengan apakah ikut ambil bagian dalam penelitiann tanpa risiko yang merugikan pada penelitian ini.

4.11.7 Inducements

Penelitian harus dihindari dari kecurigaan atas klaim adanya “eksploitatif” terhadap subjek yang berkaitan dengan aspek manfaat dan bahaya (*benefit and harm*) kerentanan (*vulnerability*) dan persetujuan (*consent*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K. (2024). PENGARUH VIDEO EDUKASI TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PERAWATAN PASCA OPERASI KATARAK DI POLI MATA RUMAH SAKIT SARI ASIH KARAWACI TANGERANG.
- Arif, T., Fauziah, M. N., & Astuti, E. S. (2022). Pengaruh Pemberian Edukasi Persiapan Pre Operatif Melalui Multimedia Video Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Elektif. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 11(2), 174–181.
- Azizah, M., & Zainuri, I. (2023a). PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI KATARAK DI RUANG OK MATA RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN.
- Azizah, M., & Zainuri, I. (2023b). PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI KATARAK DI RUANG OK MATA RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN.
- Deliya, D., Wiyono, J., & Ciptaningtyas, M. D. (2024). Pengaruh Kombinasi Aromaterapi Mawar Dan Edukasi Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Pembedahan Elektif Di RSUD dr. Soedomo Trenggalek. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 9(4).
- Gustari, L. A., & Riswanto, N. K. (2024). Prinsip dasar dan etika dalam penelitian ilmiah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 486–494.
- Hasan, N. S., Agustriyani, F., & Susanto, A. (2024). Pengaruh Edukasi Tindakan Phacomulsifikasi terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre-Op Katarak di Rumah Sakit Mata LEC. *Health Research Journal of Indonesia*, 2(5), 307–312.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil kesehatan Indonesia tahun 2021. Kemenkes RI.
- Lestari, A. M., Kurniawati, A., Syaefudin, A., & Handayani, D. R. (2024). Hubungan Pengetahuan Perioperatif dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre Operasi Katarak di RSU Bhakti Asih Tangerang. *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*, 2(1), 292–299.
- Nugraha, M., Purwato, T., & Hidayati, N. D. (2024). TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN PRA-OPERASI KATARAK DI RSUD SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA. *Jurnal Optometris*, 2(1), 1–11.
- Nursalam. (2020). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi ke-5. Salemba Medika.

Septianawati, P., Pratama, T. S., Kusumo, M. H. B., & Maulana, A. M. (2023). UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS HRAS DAN NDI VERSI INDONESIA UNTUK MENGUKUR KECEMASAN DAN DISPEPSIA PADA MAHASISWA KEDOKTERAN TAHUN PERTAMA. *PSIKOLOGI KONSELING*, 15(2), 347–357.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Wihartini. (2022). PENGARUH EDUKASI KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI ELEKTIF DI RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO.

Yahya, M. (2023). Hubungan Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak. *Darussalam Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 5(2), 86–94.

Yahya, M., Nurisa, & Zulkarnaini². (2023). Hubungan Pengetahuan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Pre Operasi Katarak. *Darussalam Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 5(2), 86–94.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN

Saya Firdhausi Nuzula mahasiswa program studi ilmu keperawatan fakultas keperawatan Sekolah Tinggi Kesehatan Kandedes ini meminta bapak/ibu/saudara untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo. Perlakuan yang diberikan terapi edukasi bagi pasien katarak yang diharapkan peneliti adalah wawasan mengenai pre operasi katarak.

Penelitian ini berlangsung selama 3 hari mulai bulan Agustus 2025 dengan sampel berupa pasien terdiagnosis katarak yang sedang menjalani kontrol di poli bedah rumah sakit Prima Husada Sukorejo yang akan pemberian edukasi dan didapatkan datanya melalui pengisian kuesioner.

Keuntungan yang bapak/ibu/saudara peroleh dengan keikutsertaan bapak/ibu/saudara adalah berupa manfaat langsung yang bapak/ibu/saudara peroleh yaitu dapat mengetahui edukasi pre operasi katarak sebagai terapi non farmakologi pasien katarak, serta manfaat tidak langsung yang dapat diperoleh yang menurunkan kecemasan. Pemberian edukasi ini selama 1 hari dengan durasi 15-20 menit.

Pada penelitian ini, prosedur pemilihan subjek yaitu dengan mendapatkan data pasien katarak dari ruangan poli bedah rumah sakit Prima Husada Sukorejo dan memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Mengingat bapak/ibu/saudara untuk mengikuti penelitian ini setelah penjelasan penelitian.

Prosedur pengambilan sampel adalah dilakukan dengan cara melihat data subjek yang diperoleh dari poli bedah rumah sakit Prima Husada Sukorejo, lalu menghitung jumlah sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan, memberikan *informed consent* pada subjek penelitian, dan subjek penelitian yang telah bersedia akan didata dan dikumpulkan dalam tabel nama, kemudian penelitian akan membagi subjek penelitian secara *total sampling*. Cara ini mungkin akan menyita waktu dan sedikit kurang nyaman, tetapi bapak/ibu/saudara tidak perlu khawatir karena pembagian akan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Setelah bapak/ibu/saudara menyatakan kesediaan berpartisipasi dalam penelitian ini, maka peneliti memastikan bapak/ibu/saudara dalam keadaan sehat. Sebelum pengisian kuesioner, peneliti akan menerangkan cara menjawab pertanyaan kepada bapak/ibu/saudara, selama 3 menit, dengan menjelaskan secara lisan, dan jawaban nanti dapat disesuaikan dengan pengalaman yang bapak/ibu/saudara alami.

Bapak/ibu/saudara dapat memberikan umpan balik dan saran pada peneliti terkait dengan proses pengambilan data dengan baik selama maupun setelah proses pengisian kuesioner. Jika bapak/ibu/saudara menyatakan bersedia menjadi responden namun disaat penelitian berlangsung anda ingin berhenti, maka

bapak/ibu/saudara dapat menyatakan mengundurkan diri atau tidak melanjutkan ikut dalam penelitian ini. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada bapak/ibu/saudara terkait hal ini. Nama dan jati diri bapak/ibu/saudara akan tetap dirahasiakan, sehingga diharapkan bapak/ibu/saudara tidak merasa khawatir dan dapat menjawab pertanyaan sesuai kenyataan dan pengalaman bapak/ibu/saudara yang sebenarnya.

Perlu bapak/ibu/saudara ketahui bahwa penelitian ini telah mendapatkan persetujuan kelaikan etik dari Komisi Etik Penelitian, sehingga bapak/ibu/saudara tidak perlu khawatir karena penelitian ini akan dijalankan dengan menerapkan prinsip etik penelitian yang berlaku. Hasil penelitian ini kelak akan dipublikasikan namun tidak terdapat identitas bapak/ibu/saudara dalam publikasi tersebut sesuai dengan prinsip etik yang diharapkan. Peneliti akan bertanggung jawab secara penuh terhadap kerahasiaan data yang bapak/ibu/saudara berikan dengan menyimpan data hasil penelitian yang hanya dapat diakses oleh peneliti.

Peneliti Utama

(Firdhausi Nuzula)

Lampiran 2

PENGANTAR INFORMED CONSENT

Judul Penelitian : Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan
Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada
Sukorejo

Peneliti : Firdhausi Nuzula

Saya adalah mahasiswa STIKes Kandedes Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan. Dalam rangka untuk menyelesaikan Proposal, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo”.

Saya berkeyakinan bahwa penelitian ini memiliki manfaat luas, baik untuk institusi pelayanan Kesehatan khususnya rumah sakit dalam intervensi non-farmakologi pada pasien katarak, maupun personal ssebagai menurunkan kecemasan pada pasien pre operasi katarak.

Apabila sejawat bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian saya ini, silahkan sejawat menandatangani persetujuan menjadi subjek penelitian. Atas kesedian dan kerjasamnya saya ucapkan terimakasih.

Malang.....2025

Peneliti Utama

(Firdhausi Nuzula)

Lampiran 3

Pernyataan Persetujuan Untuk Berpartisipasi dalam Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah mengerti tentang apa yang tercantum dalam lembar penjelasan dan telah dijelaskan oleh peneliti.
2. Dengan ini saya menyatakan bahwa secara sukarela bersedia untuk ikut serta menjadi salah subyek penelitian yang berjudul Pengaruh Edukasi Pengetahuan Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Katarak Di Poli RS Prima Husada Sukorejo.

Malang,.....2025

Peneliti

Yang membuat pernyataan

(Firdhausi Nuzula)

(.....)

Lampiran 4

DATA PASIEN

Kode Responden:.....

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia : tahun

Lama Penyakit:

Alamat :

No.Hp :

Malang,.....2025

(.....)

Lampiran 5

LEMBAR KUESIONER HAMILTON RATING FOR ANXIETY (HARS)

No.Kode :

Tanggal penelitian :

Petunjuk Pengisian

Isilah dengan memberi tanda “√” (contreng) pada kotak jawaban yang anda pilih dibawah ini sesuai dengan perasaan anda saat ini. Pengisian tidak mengandung pertanyaan benar atau salah, jadi isilah sesuai apa yang anda rasakan. Anda boleh mengisi lebih dari satu, dua atau semua kotak contrengan jika anda merasakan hal tersebut pada diri anda. Pada kotak bagian kanan (skor) tidak perlu anda isi.

1. Respon Cemas

()	Firasat buruk	Skor
()	Takut akan pikiran sendiri	()
()	Mudah tersinggung	

2. Ketegangan

()	Merasa tegang	Skor
()	Lesu	()
()	Mudah terkejut	
()	Tidak dapat istirahat dengan nyenyak	
()	Mudah menangis	
()	Gemetar	
()	Gelisah	

3. Ketakutan

()	Takut pada tindakan operasi	
-----	-----------------------------	--

- | | | |
|--------|---|----------------|
| () | Takut akan efek samping operasi | Skor |
| () | Takut tidak akan kembali keadaan normal | () |
| () | Takut biaya operasi | |

4. Gangguan Tidur

- | | | |
|--------|------------------------|----------------|
| () | Sukar memulai tidur | Skor |
| () | Terbangun tengah malam | () |
| () | Tidak puas | |
| () | Mimpi buruk | |
| () | Mimpi yang menakutkan | |

5. Gangguan Kecerdasan

- | | | |
|--------|----------------------|----------------|
| () | Daya ingat buruk | Skor |
| () | Sulit berkonsentrasi | () |
| () | Sering bingung | |

6. Perasaan Depresi

- | | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| () | Kehilangan minat | |
| () | Sedih | Skor |
| () | Bangun dini hari/tengah malam | () |
| () | Berkurang kesukaan pada hobi | |
| () | Perasaan berubah-ubah sepanjang hari | |

7. Gejala Somatik (Otot-Otot)

- | | | |
|--------|--------------|----------------|
| () | Nyeri otot | Skor |
| () | Kaku | () |
| () | Kedutan otot | |

() Suara tak stabil

() Telinga berdenging Skor

() Kerongkongan kering ()

() Muka merah dan pucat

() Merasa lelah

() Perasaan ditusuk-tusuk

() Denyut nadi cepat Skor

() Berdebar-debar ()

() Nyeri dada

() Denyut nadi mengeras

() Rasa lemah seperti mau pingsan

() Detak jantung hilang sekejap

() Rasa tertekan di dada Skor

() Perasaan tercekik ()

() Merasa napas pendek/sesak

() Sering menarik napas panjang

() Sulit menelan Skor

() Mual muntah ()

- () Berat badan menurun
- () Konstipasi (sulit buang air besar)
- () Perut melilit
- () Gangguan pencernaan
- () Nyeri lambung sebelum/sesudah makan
- () Rasa panas diperut
- () Perut terasa penuh/kembung

12. Gejala Urogenitalia (Perkemihan)

- | | |
|---|-----------------|
| () Sering kencing | Skor |
| () Tidak dapat menahan kencing | () |
| () Menstruasi tidak lancar dan teratur | |
| () Frigiditas | |

13. Gejala Vegetatif/ Otonom

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| () Mulut kering | Skor |
| () Muka kering | () |
| () Mudah berkeringat | |
| () Pusing/sakit kepala | |
| () Bulu roma/kuduk berdiri | |

14. Perilaku Sewaktu-Waktu

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| () Gelisah | Skor |
| () Tidak tenang | () |
| () Mengerutkan dahi | |
| () Ketegangan otot meningkat | |

() Napas pendek dan cepat

() Muka merah

Cara penilaian :

- Skor 0 : tidak ada gejala sama sekali
- Skor 1 : satu dari gejala yang ada
- Skor 2 : separuh dari gejala yang ada
- Skor 3 : lebih dari separuh gejala yang ada
- Skor 4 : semua gejala ada

Penilaian hasil yaitu dengan menjumlahkan nilai skor item 1 sampai dengan 14

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Skor kurang dari 6 : tidak ada kecemasan
- Skor 6-14 : kecemasan ringan
- Skor 15 -27 : kecemasan sedang
- Skor lebih dari 28 : kecemasan berat

Lampiran 6

LEMBAR OBSERVASI PEMBERIAN EDUKASI KESEHATAN

[illegible]

Lampiran 7

Satuan Acara Penyuluhan

Pokok Bahasan : Persiapan, Proses, dan Perawatan Mata Operasi Katarak
Sasaran : Pasien Pre Operasi Katarak
Tempat Kegiatan : Ruang Poli RS Prima Husada Sukorejo
Hari/Tanggal/Jam : Menyesuaikan
Alokasi Waktu : 15-20menit
Edukator :

A. Tujuan Instruksional

1. Tujuan Umum

Setelah diberikan penyuluhan selama 15-20 menit, diharapkan pasien memahami tentang persiapan sebelum operasi katarak serta pasien siap secara mental untuk menjalani operasi katarak.

2. Tujuan Khusus

Setelah diberikan penyuluhan selama 15-20 menit, diharapkan dapat:

- Mengetahui tentang pengertian katarak
- Mengetahui tanda dan gejala katarak
- Mengetahui tujuan operasi katarak
- Mengetahui tentang proses operasi katarak
- Mengetahui tentang perawatan mata setelah pembedahan katarak

B. Sasaran

Pasien pre operasi katarak di ruang Poli RS Prima Husada Sukorejo

C. Metode

Ceramah, tanya jawab, diskusi

D. Media

Leaflet

E. Kegiatan Penyuluhan

Tahap	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta	Metode	Media
Pembukaan	3 menit	1. Membuka kegiatan dengan mengucakan salam 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan maksud dan tujuan penyuluhan 4. Kontrak waktu	Menjawab salam Mendengarkan Memperhatikan	Ceramah	

		5. Menggali pengetahuan peserta sebelum memberikan materi penyuluhan 6. Pretest			
Penyajian	10 menit	Menjelaskan tentang: 1. Mengetahui tentang pengertian katarak 2. Mengetahui tanda dan gejala katarak 3. Mengetahui tujuan operasi katarak 4. Mengetahui tentang proses operasi katarak 5. Mengetahui tentang perawatan mata setelah pembedahan katarak	1. Mendengarkan dan memperhatikan 2. Mmemberikan tanggapan dan pertanyaan mengenai hal yang kurang dimengerti	Ceramah, tanya jawab	Leaflet
Penutup	7 menit	1. Menggali pengetahuan peserta setelah dilakukan penyuluhan (posttest), menyimpulkan hasil kegiatan penyuluhan 2. Menutup dengan salam			

F. Kriteria Evaluasi

1. Struktur

- Mendapatkan perizinan kepada pihak rumah sakit mengenai kegiatan penyuluhan beberapa hari sebelum acara.
- Materi dan media siap sebelum penyuluhan dilakukan.
- Sarana dan prasarana siap sebelum penyuluhan dilakukan.
- Menyusun anggota penyuluhan.

2. Proses

- Media yang digunakan adalah leaflet.
- Waktu penyuluhan 15-20 menit.
- Tidak ada peserta meninggalkan tempat penyuluhan saat kegiatan berlangsung.
- Peserta aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.

3. Hasil

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, peserta diharapkan mengalami peningkatan pengetahuan tentang perawatan setelah operasi katarak dan cuci tangan dengan indikator 90% pasien mampu menjawab 3 dari 4 tujuan khusus.

G. Materi Penyuluhan
(Lampiran 1)

H. Daftar Pustaka
(Lampiran 2)

Lampiran 8

MATERI PENYULUHAN

A. Pengertian Katarak

Katarak adalah salah satu penyakit karena kekeruhan pada lensa mata yang berada di dalam bola mata. Kekeruhan lensa atau katarak akan mengakibatkan cahaya terhalang untuk masuk ke dalam mata sehingga penglihatan menjadi menurun (Lestari dkk., 2024).

B. Tanda dan Gejala Katarak

Manifestasi klinis katarak menurut Lestari dkk (2024) antara lain:

1. Pandangan mata menjadi kabur.
 2. Merasa silau bila terkena cahaya
 3. Mata melihat cincin dari sumber cahaya.
 4. Gambar menjadi ganda.
 5. Saat malam penglihatan nampak buruk.
- Penglihatan ganda atau banyak gambar dalam satu mata.

C. Tujuan dan Manfaat Operasi Katarak

Untuk meningkatkan tajam penglihatan (memperbaiki visus) dengan cara menghilangkan lensa yang berkabut pada mata. Manfaat yang didapat adalah mata pasien tidak kabur dan dapat melihat normal.

D. Proses Operasi

1. Pasien sebelum tindakan operasi diberikan obat tetes midriatil yang bertujuan agar pupil mata pasien midriasis/ lebar dan untuk mempermudah saat proses pembedahan dilakukan.
2. Pasien diberikan penanda pada mata yang akan dilakukan tindakan
3. Pasien dijelaskan prosedur tindakan operasi yang akan dilakukan meliputi: nama tindakan, tujuan dari tindakan yang dilakukan, perawatan yang dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan.
4. Pasien di pindahkan ke ruang pre operasi dan dipakaikan baju steril
5. Pasien diberitahu bahwa operasi katarak akan segera dimulai.
6. Tim operasi mempersiapkan perlengkapan alat.
7. Mata pasien diberikan obat tetes pantocain sebagai anastesi lokal
8. Mata yang akan dilakukan tindakan operasi di desinfeksi dengan betadine untuk meminalisir terjadinya infeksi
9. Pasien dilakukan drapping pada area operasi
10. Pasien dilakukan tindakan pembedahan katarak dengan mesin phaco
11. Lensa yang keruh disedot menggunakan mesin
12. Lensa buatan/tanam dipasang di mata pasien
13. Diberikan obat tetes antibiotik
14. Tutup mata pasien dengan kassa steril dan eyedop yang bertujuan agar terhindar dari infeksi
15. Pembedahan katarak telah selesai.
16. Pasien digantikan baju
17. Pasien mengambil obat di farmasi
18. Kontrol H+1 setelah operasi untuk membuka perban

E. Perawatan Mata Setelah Operasi Katarak

1. Hal-hal yang boleh dilakukan setelah operasi katarak.
 - a. Memakai dan meneteskan obat seperti yang dianjurkan.
 - b. Pakai Penutup mata seperti yang dinasehatkan.
 - c. Melakukan pekerjaan hanya tidak berat.
 - d. Bila memakai sepatu jangan membungkuk, tetapi angkat kaki keatas.
2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah operasi katarak
 - a. Jangan menggosok mata
 - b. Jangan membungkuk terlalu dalam
 - c. Jangan menggendong yang berat
 - d. Jangan membaca berlebihan dari biasanya
 - e. Jangan mengejan keras sewaktu buang air besar
 - f. Jangan berbaring kesisi mata yang baru dibedah
 - g. Jangan menggosok gigi pada minggu pertama dan coba mencuci mulut saja.

Lampiran 9

Langkah- Langkah

1. Pasien diberi informasi tentang tujuan dan manfaat operasi katarak.
2. Sebelum dilakukan operasi mata pasien ditetesin obat tetes mata.
3. Mata pasien diberi anestesi, lalu dibersihkan.
4. Setelah itu lensa mata yang rusak diganti dengan lensa buatan.
5. Kemudian bekas sayatan dibagian mata dijahit dan dikasih saleb, mata yang dioperasi ditutup dengan perban dan pelindung mata.

PERAWATAN POST OPERASI



1. Perawatan post operasi katarak adalah dianjurkan memakai obat tetes, memakai penutup mata, dan tidak melakukan pekerjaan berat.
2. Pasien setelah operasi katarak dilarang mengucek mata, jangan membaca terlalu berlebihan, dan lain sebagainya.

KATARAK



**PRIMA HUSADA
Hospital**

KATARAK

Katarak adalah disebabkan adanya kekeruhan di lensa dalam bola mata

Tanda gejala katarak salah satunya adalah pandangan kabur dan pada malam hari penglihatan buruk



Tujuan Operasi

Meningkat penglihatan pasien yang mengalami katarak

MANFAAT

Manfaat yang didapatkan operasi katarak adalah kekeruhan yang ada di lensa mata sudah tidak ada dan pandangan mata tidak kabur.

